



Curso

ATENÇÃO À SAÚDE DA CAMINHONEIRA E CAMINHONEIRO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Módulo III

**Saúde Mental da Caminhoneira e do
Caminhoneiro**

Fiocruz Mato Grosso do Sul

AUTOR

Elder Cerqueira-Santos – <https://lattes.cnpq.br/4789244353614950>

SUMÁRIO

- 3.1 O cuidado em saúde mental da caminhoneira e do caminhoneiro na Atenção Primária à Saúde**
- 3.2 O uso de álcool e outras drogas no contexto das rodovias, com ênfase na redução de danos**
- 3.3 Principais transtornos relacionados à saúde mental nas estradas**
- 3.4 A relação entre privação do sono e saúde mental**
- 3.5 Família, solidão e distanciamento social**
- 3.6 A importância dos grupos e da educação em saúde na abordagem à saúde mental**

APRESENTAÇÃO DO MÓDULO

Chegamos ao Módulo III! Nos módulos anteriores, você refletiu a respeito das condições de vida e trabalho da caminhoneira e do caminhoneiro e o cuidado integral. Agora, damos um passo além: olhar com atenção para a **saúde mental nas estradas** e o papel estratégico da Atenção Primária à Saúde (APS) nesse cuidado.

Você já parou para pensar em como o ritmo intenso, os prazos apertados, a distância da família e a privação de sono impactam pensamentos, emoções e comportamentos? A vida sobre rodas excede o desgaste físico, e é justamente aí que a saúde mental torna-se central.

Neste módulo, vamos entender como identificar sinais de sofrimento psíquico, acolher sem julgamento e construir vínculo com quem passa grande parte do tempo fora do próprio território. Também abordaremos o **uso de álcool e outras drogas**, discutindo a redução de danos como abordagem ética e centrada no cuidado, sem juízo de valor.

Você encontrará reflexões sobre ansiedade, depressão, transtornos do sono, relações familiares e solidão. Além disso, vamos pensar quanto ao papel dos **grupos e ações educativas** na produção de pertencimento e acesso ao cuidado. A pergunta que nos guia é: que possibilidades podem ser construídas para que a saúde mental da caminhoneira e do caminhoneiro seja reconhecida como prioridade na APS?

Vamos juntos encontrar essa resposta?

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Identificar determinantes sociais e laborais relacionados à saúde mental das caminhoneiras e dos caminhoneiros.
2. Analisar a dinâmica do uso de álcool e outras drogas no contexto das rodovias, com ênfase em estratégias de redução de danos.
3. Reconhecer os principais transtornos mentais associados à atividade profissional nas estradas.
4. Analisar os impactos da privação do sono na saúde mental e segurança na direção.
5. Compreender estratégias de intervenção na APS, incluindo grupos, educação em saúde e articulação comunitária.

CARGA HORÁRIA DE ESTUDO

07 horas.

TEXTO-BASE

3.1 O cuidado em saúde mental da caminhoneira e do caminhoneiro na Atenção Primária à Saúde

O cuidado em saúde mental das pessoas caminhoneiras na Atenção Primária à Saúde (APS) exige o reconhecimento das especificidades do trabalho nas estradas e a articulação das políticas públicas já existentes no Sistema Único de Saúde (SUS). Você sabia, por exemplo, que a dinâmica da profissão é regulamentada pela Lei nº 13.103/2015, que estabelece direitos e deveres relacionados à jornada de trabalho, tempo de descanso e condições de exercício profissional? Embora represente um avanço na proteção trabalhista, a realidade cotidiana ainda é marcada por longas jornadas, pressão por prazos, insegurança nas rodovias e dificuldades de acesso regular aos serviços de saúde, fatores que impactam diretamente a saúde mental.

Estudos como o de Masson e Monteiro (2010) mostram que o estilo de vida de motoristas de caminhão envolve sedentarismo, alimentação inadequada, uso de substâncias psicoativas, privação de sono e estresse ocupacional. Essas condições favorecem ansiedade, depressão, irritabilidade, distúrbios do sono e sofrimento psíquico associado ao isolamento social. Além disso, pesquisas mais recentes, como a de Cerqueira-Santos e Santana (2014), indicam diferenças na satisfação entre motoristas autônomos e empregados, destacando que vínculo laboral, estabilidade financeira e reconhecimento profissional influenciam o bem-estar mental.

Então, o que fazer diante desse cenário? Nesse ponto, a APS ocupa posição estratégica! Como principal porta de entrada do SUS, ela deve operar segundo os princípios da integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado. A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) orienta que o cuidado em saúde mental seja territorial, comunitário e centrado na pessoa, superando modelos exclusivamente hospitalocêntricos.

Reflexão

Você já pensou como seria possível aplicar esses princípios e orientações considerando no contexto de vida e trabalho da população caminhoneira?

Para isso, seria preciso flexibilizar estratégias de acesso, fortalecer ações extramuros, articular parcerias intersetoriais e considerar a itinerância como elemento estruturante do cuidado.

A organização do cuidado deve dialogar com a Portaria nº 3.088/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A APS, como componente fundamental da RAPS, é responsável por acolhimento, identificação precoce de sofrimento psíquico, manejo inicial dos transtornos mentais comuns, acompanhamento longitudinal e encaminhamento, quando necessário, para Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e outros pontos da rede.

Saiba que, no caso de caminhoneiras e caminhoneiros, o vínculo pode ser fortalecido por meio de escuta qualificada e rastreamento de sintomas relacionados a estresse, depressão, ansiedade e uso de álcool e outras drogas, além da oferta de ações educativas em saúde voltadas à higiene do sono, redução de danos e promoção de estilos de vida mais saudáveis. No Quadro 1 é possível visualizar um esquema para orientar melhor essa identificação.

Quadro 1. Identificação de sofrimento em saúde mental na Atenção Primária à Saúde

Sinais de alerta	O que observar	Conduta na Atenção
-------------------------	-----------------------	---------------------------

		Primária à Saúde
Humor deprimido	Tristeza, irritabilidade	Escuta + rastreio
Ansiedade	Inquietação	Orientação
Estresse	Cansaço extremo	Intervenção breve
Privação de sono	Fadiga	Educação do sono
Uso de substâncias	Relato/suspeita	Redução de danos

Fonte: elaboração do autor, 2026, a partir de APA, 2014.

É fundamental reconhecer que o cuidado em saúde mental da caminhoneira e do caminhoneiro não se limita ao tratamento de transtornos diagnosticados; ele envolve a compreensão das condições concretas de trabalho, da solidão nas estradas, do distanciamento familiar e da pressão produtiva que atravessam o cotidiano profissional. Nesse sentido, a APS pode atuar tanto na dimensão clínica quanto na promoção da saúde, organizando grupos educativos, rodas de conversa e estratégias itinerantes nos Pontos de Parada e Descanso (PPD), contribuindo para a construção de redes de apoio e para o fortalecimento do protagonismo desses trabalhadores.

Assim, o cuidado em saúde mental de caminhoneiras na APS demanda sensibilidade às singularidades do trabalho rodoviário, articulação com a legislação vigente e integração efetiva à RAPS. Ao reconhecer esses sujeitos como trabalhadores de direitos e como pessoas inseridas em contextos complexos de vida e trabalho, a APS reafirma seu papel nuclear na promoção da saúde, na prevenção de agravos e na produção de cuidado integral no SUS.

Saiba mais

Assista ao vídeo introdutório com duração de 1 min, gravado pelo Prof. Elder com o objetivo de justificar e argumentar a relevância e especificidade do tema. Nele, você conhecerá dados de pesquisa e intervenção em saúde, bem como de comportamento das caminhoneiras e dos caminhoneiros.

Disponível

em:

<https://drive.google.com/file/d/1ZOOMg7SdgsN2VJGsGNmbK9O57ZtaQ1Le/view?usp=sharing>.

3.2 O uso de álcool e outras drogas no contexto das rodovias, com ênfase na redução de danos

Você já parou para pensar por que muitas pessoas caminhoneiras fazem uso de álcool ou outras substâncias? É importante entender que não se trata de uma escolha aleatória, de

modo que esse uso está diretamente relacionado às condições de trabalho: jornadas longas, cansaço acumulado, pressão por produtividade e a necessidade de permanecer acordado por horas — às vezes, dias.

Os dados confirmam essa realidade. Em rodovias do estado de São Paulo, 67,3% das pessoas caminhoneiras relataram consumo recente de álcool; 34,6% apresentaram consumo pesado e 26% relataram episódios de *binge drinking* (beber grande quantidade de álcool de uma só vez). Além disso, 54,6% combinavam álcool com outras substâncias, como tabaco e energéticos (Leopoldo; Leyton; Oliveira, 2015). Estudos anteriores já apontavam que até 91% consumiram álcool durante viagens e 66% admitiram usar anfetaminas para aguentar o ritmo de trabalho (Nascimento; Nascimento; Silva, 2007). Dados mais recentes indicam crescimento no uso de cocaína e outros estimulantes, muitas vezes chamados de “rebites”, usados com frequência para não dormir (Childhood Brasil, 2025) — substâncias estas associadas a mais de 6 mil acidentes e 452 mortes em rodovias federais em um único ano (PRF, 2023).

Diante desse cenário, qual é o papel da APS? A abordagem mais adequada é a **redução de danos**: uma estratégia ética, realista e não moralizante, centrada na compreensão das experiências e necessidades de cada pessoa. Em vez de julgamento, oferece orientação, acolhimento e construção conjunta de possibilidades, mesmo que a mudança seja gradual. Conheça algumas estratégias no Quadro 2.

Quadro 2. Redução de danos na prática

Situação	Abordagem na Atenção Primária à Saúde
Uso de álcool	Orientar sobre riscos; evitar dirigir após consumo
Uso de estimulantes	Explorar motivações; discutir alternativas
Estresse e cansaço	Propor estratégias não farmacológicas
Resistência à mudança	Trabalhar metas graduais e possíveis
Sofrimento associado	Avaliar saúde mental; acionar rede se necessário

Fonte: elaboração do autor, 2026.

É importante saber que a redução de danos não exige que a pessoa abandone imediatamente o uso de substâncias; ela propõe que cada passo em direção ao menor risco já seja um avanço, e que o cuidado começa no vínculo, não no julgamento.

3.3 Principais transtornos relacionados à saúde mental nas estradas

Você já parou para pensar em transtornos mentais de profissionais que dirigem e têm alta dificuldade de atendimento psicológico continuado? Um estudo recente da Universidade Federal de Sergipe, com apoio da Childhood Brasil, chama a atenção para esse tema pouco discutido (Viana; Feitosa; Cerqueira-Santos, 2025). A pesquisa ouviu 273 profissionais de todo o país e revelou um cenário preocupante. Os números impressionam: 41% apresentaram sintomas de depressão, 47,3% de ansiedade e 71,1% de estresse. Ou seja, a maioria desse público-alvo convive com alta carga emocional no dia a dia. E o mais importante: esses problemas estão muito mais ligados às condições de trabalho do que a fatores pessoais, como renda ou escolaridade.

Pense, por exemplo, no tempo longe de casa: caminhoneiras e caminhoneiros que passam mais de 15 dias na estrada têm mais que o dobro de chance de sintomas de depressão e ansiedade. Nesse sentido, a distância da família e a solidão pesam. Outro ponto crítico é a espera por carga: ficar mais de 24 horas aguardando, muitas vezes sem estrutura adequada, aumenta significativamente o risco de sofrimento psicológico.

Nesse contexto, o sofrimento psíquico dos caminhoneiros não pode ser entendido como uma fragilidade individual, pois há outro elemento importante no quadro: a cultura das masculinidades. Conforme tratado no Módulo II, essa é uma profissão com predominância masculina e, por isso, carrega valores que frequentemente associam força ao silêncio e à resistência. Isso desestimula o autocuidado e cria barreiras para que homens busquem ajuda, mesmo quando estão sofrendo. Por mais que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) reconheça essa realidade, a saúde mental ainda ocupa espaço secundário nas ações dirigidas a esse público. Cabe à APS criar espaços que rompam esse silêncio, sem julgamento e sem reforçar estereótipos.

Na prática, o cuidado passa por reconhecer sinais precoces, acolher sem julgamento, facilitar o acesso e articular com a rede quando necessário, lembrando sempre que, mais do que diagnosticar, é preciso que você, como profissional, compreenda o contexto de vida de quem está na sua frente.

3.4 A relação entre privação do sono e saúde mental

Quando falamos em saúde mental de caminhoneiras e caminhoneiros, é impossível não tratar de sono ou, mais precisamente, da ausência dele. Você já parou para imaginar o que significa dirigir por horas seguidas, parando para dormir brevemente em locais improvisados, muitas vezes barulhentos e inseguros?

A privação do sono não é apenas um desconforto passageiro. O estudo de Knauth *et al.* (2012) mostra que “manter-se acordado” é, para essas pessoas, uma exigência imposta pela lógica do trabalho nas rodovias: prazos apertados, pagamento por produtividade, longas distâncias e tempo de espera obrigam o adiamento contínuo do descanso. Dorme-se quando dá; dorme-se onde é possível.

As consequências ultrapassam o cansaço físico, uma vez que o sono regula emoções, atenção e tomada de decisão. Quando é reduzido ou fragmentado, surgem irritabilidade, lapsos de memória, dificuldade de concentração e maior propensão a sintomas ansiosos e depressivos. Para contornar isso, muitas pessoas recorrem a estimulantes, criando um ciclo perigoso: menos sono, mais desgaste, maior dependência de substâncias para continuar dirigindo. No Quadro 3, observe alguns desses impactos e as condutas a serem seguidas na APS.

Quadro 3. Privação do sono: impactos e condutas na Atenção Primária à Saúde

Fator	Impacto	Conduta na Atenção Primária à Saúde
Poucas horas de sono	Fadiga, irritabilidade	Orientar pausas e descanso
Sono fragmentado	Déficit cognitivo	Higiene do sono
Uso de estimulantes	Risco de dependência	Redução de danos
Jornadas longas	Estresse crônico	Sensibilização e escuta

Fonte: elaboração do autor, 2026.

Promover saúde mental entre caminhoneiras e caminhoneiros exige, portanto, incluir o sono como eixo central do cuidado. Não se trata apenas de orientar a “dormir mais”, mas de

criar condições reais para que o descanso seja possível, o que envolve políticas, pausas efetivas e locais adequados de repouso.

Reflexão

Quando você atende uma pessoa caminhoneira na APS, costuma perguntar apenas “quantas horas dorme”, ou também investiga como ela dorme, isto é, a qualidade desse sono? Essa diferença pode ser decisiva no cuidado.

3.5 Família, solidão e distanciamento social

Estradas longas, prazos, cargas... esses elementos são visíveis na vida de caminhoneiras e caminhoneiros. Mas há algo que nem sempre aparece à primeira vista: a distância. Distância de casa, da família, dos filhos, das rotinas afetivas. E essa distância, com o tempo, pode se transformar em solidão.

Passar mais de quinze dias fora de casa de forma recorrente não é apenas um detalhe da profissão; é um fator que impacta diretamente a saúde mental. A rotina intensa e a irregularidade de horários fragilizam o contato: ligações rápidas, mensagens interrompidas pelo sinal instável, aniversários e comemorações perdidos — tudo isso se acumula. Estudos indicam que a fragilidade de vínculos afetivos se associa a maior risco de sintomas depressivos, especialmente entre pessoas mais velhas (Viana; Feitosa; Cerqueira-Santos, 2025).

A rotina itinerante também dificulta a construção de relações duradouras fora do ambiente familiar. As interações no cotidiano das estradas — com colegas de profissão, frentistas, funcionários de pontos de apoio — tendem a ser superficiais e transitórias. O resultado disso pode ser uma experiência paradoxal: estar sempre em movimento, cercado de pessoas, mas sentir-se profundamente sozinho.

Existe ainda uma tensão silenciosa e frequente: a necessidade de prover financeiramente a família, vista por muitos como expressão de responsabilidade e identidade, exige justamente o afastamento da convivência com ela. Esse **conflito entre prover e estar presente** pode gerar sofrimento que raramente é nomeado ou reconhecido. Observe, no Quadro 4, alguns fatores psicossociais e impactos na saúde mental no contexto dessa população.

Quadro 4. Fatores psicossociais e impactos na saúde mental

Fator psicossocial	Impacto na saúde mental
Distância familiar prolongada	Solidão; saudade; culpa
Longos períodos fora de casa	Isolamento; depressão
Pressão por produtividade	Ansiedade; estresse
Espera prolongada	Frustração; irritabilidade
Normas de masculinidade	Baixa busca por cuidado

Fonte: elaboração do autor, 2026.

Consequentemente, o cuidado em saúde mental precisa incluir a dimensão relacional: fortalecer vínculos, criar espaços de escuta, usar tecnologias como apoio à comunicação familiar e desenvolver ações voltadas à saúde do homem e da mulher são caminhos concretos que a APS pode percorrer. Reduzir o impacto da solidão não é apenas uma questão afetiva; é uma estratégia de promoção de saúde.

Saiba mais

Ouçá o *podcast* que tem duração de 10 min, com participação dos professores Elder Cerqueira-Santos e João Paulo Feitosa em entrevista que aborda os efeitos da solidão na saúde mental.

Disponível

em:

https://drive.google.com/file/d/1_4QXRb-gWJZyJL91krmnKhNb0iloUiEQ/view?usp=sharing.

3.6 A importância dos grupos e da educação em saúde na abordagem à saúde mental

Ao longo deste módulo, vimos como as condições de trabalho, a privação do sono, o uso de substâncias e o distanciamento familiar abalam profundamente a saúde mental de caminhoneiras e caminhoneiros. Diante de tantos fatores de risco, surge uma pergunta

essencial: o que pode funcionar como fator de proteção? É aqui que entram os grupos e a educação em saúde como estratégias fundamentais de cuidado.

Pense comigo: se a solidão é um dos elementos que atravessam a vida nas estradas, criar espaços coletivos de troca já é, por si só, uma intervenção potente. Grupos de apoio presenciais ou adaptados à realidade itinerante desses trabalhadores permitem que experiências sejam compartilhadas, que dificuldades sejam nomeadas e que o sofrimento deixe de ser vivido de forma isolada. Por exemplo, quando a caminhoneira ou o caminhoneiro percebe que outros também enfrentam ansiedade, cansaço extremo e saudade da família, ocorre algo transformador: o problema deixa de ser “fraqueza individual” e passa a ser compreendido como resultado das condições de vida e trabalho.

Isso nos mostra que intervenções precisam considerar o contexto real da profissão. Grupos em Unidades Básicas de Saúde (UBS) próximas a polos logísticos, ações em PPD e parcerias intersetoriais são caminhos possíveis.

A educação em saúde, por sua vez, amplia o alcance do cuidado. Ela não se limita à transmissão de informações; trata-se de um processo dialógico, de construção compartilhada de saberes. Quando falamos com caminhoneiras e caminhoneiros sobre saúde mental, sono, uso de álcool e outras drogas, manejo do estresse ou importância das pausas, estamos oferecendo ferramentas, a fim de que eles reconheçam sinais precoces de sofrimento e saibam quando e onde buscar ajuda.

Nesse ponto, retomamos um aspecto fundamental: a educação em saúde ajuda a romper estigmas. A partir da perspectiva de gênero, muitos homens ainda associam sofrimento psíquico à fragilidade. Ao discutir saúde mental de forma aberta, contextualizada e respeitosa, mostramos que ansiedade, depressão e estresse são respostas humanas a condições adversas, e que procurar cuidado é um ato de responsabilidade, não de fraqueza.

Além disso, grupos e ações educativas também podem fortalecer a autonomia. Ao compreender melhor os impactos da privação de sono, do isolamento social e da sobrecarga de trabalho, a pessoa caminhoneira passa a ter mais elementos para reivindicar melhores condições, negociar pausas e cuidar de si dentro das possibilidades reais de sua rotina.

Saiba mais

Como recurso complementar para aprofundar sua compreensão, sugerimos que você conheça o material do Programa Na Mão Certa (Childhood Brasil), uma iniciativa que conecta diretamente temas como caminhoneirismo, violência e sexualidade.

Disponível em: www.namaocerta.org.br.

ENCERRAMENTO DO MÓDULO

No âmbito da Atenção Primária à Saúde, as estratégias aqui apresentadas dialogam diretamente com os princípios do cuidado integral — não se trata apenas de atender a crises, mas de promover saúde, prevenir agravos e construir vínculos contínuos. A presença de equipes preparadas para acolher uma população, reconhecer suas especificidades e desenvolver ações coletivas pode fazer toda a diferença.

Ao final deste módulo, fica um convite à reflexão: cuidar da saúde mental de caminhoneiras e caminhoneiros é tanto tratar sintomas quanto criar espaços de escuta, fortalecer vínculos e promover conhecimento. Quando unimos grupos, educação em saúde e políticas públicas sensíveis à realidade das estradas, construímos caminhos mais seguros para o trânsito e para a vida. Agora você já sabe como implementar ações na APS que podem colaborar na vida desses profissionais!

REFERÊNCIAS

APA (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. Tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento *et al.* 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em: <https://membros.analysispsicologia.com.br/wp-content/uploads/2024/06/DSM-V.pdf>. Acesso em: 27 maio 2026.

BRASIL. Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015. Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) [e outras legislações relacionadas à jornada e descanso do motorista profissional]. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 3 mar. 2015. PL 4246/2012. Disponível em: www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13103-2-marco-2015-780193-norma-pl.html. Acesso em: 27 maio 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 59, 26 dez. 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html. Acesso em: 27 maio 2026.

CERQUEIRA, E. S.; SANTANA, M. V. M. Satisfação no trabalho entre profissionais do transporte rodoviário: estudo comparativo entre autônomos e empregados. **Revista de Psicologia**, v. 5, n. 1, p. 109-120, 2014. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8086132>. Acesso em: 19 fev. 2026.

CHILDHOOD BRASIL. **O Perfil do Caminhoneiro Brasileiro**. 5. ed. São Paulo: Childhood Brasil; Programa Na Mão Certa, 2025. Disponível em: <https://namaocerta.org.br/pesquisas-e-publicacoes/o-perfil-do-caminhoneiro-brasileiro-2025/>. Acesso em: 27 maio 2026.

KNAUTH, D. R. *et al.* Manter-se acordado: a vulnerabilidade dos caminhoneiros no Rio Grande do Sul. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, n. 5, p. 886-893, 2012. Disponível em: www.scielo.br/j/rsp/a/qqzWhf4Mp6TTysBf6pZCXfz/?lang=pt. Acesso em: 19 fev. 2026.

LEOPOLDO, K.; LEYTON, V.; OLIVEIRA, L. G. Uso exclusivo de álcool e em associação a outras drogas entre motoristas de caminhão que trafegam por rodovias do Estado de São Paulo, Brasil: um estudo transversal. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 31, n. 9, 2015. Disponível em: www.scielo.br/j/csp/a/vvmfh6xvtDT9xGx4xkmh4Qq/abstract/?lang=pt. Acesso em: 27 maio 2026.

MASSON, V. A.; MONTEIRO, M. I. Estilo de vida, aspectos de saúde e trabalho de motoristas de caminhão. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 63, n. 4, p. 533-540, 2010. Disponível em: www.scielo.br/j/reben/a/SfX3fnBfK7bVtFbFzMHtPD/?lang=pt. Acesso em: 19 fev. 2026.

NASCIMENTO, E. C.; NASCIMENTO, E.; SILVA, J. P. Uso de álcool e anfetaminas entre caminhoneiros de estrada. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 41, n. 2, p. 290-293, 2007. Disponível em: www.scielo.br/j/rsp/a/b9vVFYzYSf6fCH9djV9s6nH/?lang=pt. Acesso em: 27 maio 2026.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). **Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais**. Brasília: PRF, 2023. Disponível em:

www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/diest-arquivos/anuario-2023_final.html.

Acesso em: 27 maio 2026.

VIANA, S.; FEITOSA, J.; CERQUEIRA-SANTOS, E. Saúde mental de caminhoneiros: preditores demográficos e condições de trabalho. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**, Canoas, v. 13, n. 2, 2025. Disponível em:

https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/saude_desenvolvimento/article/view/12894. Acesso em: 19 fev. 2026.